Telitacicept v IgA nefropatii: interim analýza fázy 3 (TELIGAN) ukazuje výrazné zníženie proteinúrie pri vyššom výskyte nežiaducich udalostí

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 22.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Výrazný pokles proteinúrie je sprevádzaný vyšším počtom nežiaducich udalostí – pri hodnotení treba vážiť oboje.

IgA nefropatia (IgAN) patrí medzi najčastejšie primárne glomerulové ochorenia vedúce k chronickému zlyhaniu obličiek. Jednou z kľúčových biologických osí jej patogenézy je dysregulácia B buniek a signálnej dráhy sprostredkovanej faktorom aktivujúcim B bunky (BAFF, *B-cell activating factor*) a ligandom indukujúcim proliferáciu (APRIL, *a proliferation-inducing ligand*). Telitacicept je fúzny proteín, ktorý viaže a neutralizuje BAFF aj APRIL, čo z neho robí biologicky zdôvodnenú možnosť liečby IgAN.

Autori zdrojovej štúdie

Zdrojom je interim analýza štúdie **TELIGAN** publikovaná v časopise *New England Journal of Medicine* (2026). Hlavnými autormi sú **Jicheng Lv, Lijun Liu, Wenxiang Wang, Xinyue Wang, Qing Zuraw, Vlado Perkovic, Jianmin Fang** a **Hong Zhang** v mene **TELIGAN Investigators**. Štúdia je registrovaná v registri ClinicalTrials.gov pod identifikátorom NCT05799287 (financovaná spoločnosťou RemeGen).

Dizajn štúdie TELIGAN a populácia

Išlo o **multicentrickú, dvojito zaslepenú, randomizovanú a placebom kontrolovanú štúdiu fázy 3**. Zaradení boli dospelí s **biopticky potvrdenou IgA nefropatiou** a **perzistujúcou proteinúriou najmenej 1,0 g denne** napriek primeranej podpornej liečbe.

- randomizácia v pomere 1 : 1,
- intervencia: **telitacicept 240 mg subkutánne raz týždenne**,
- kontrola: zodpovedajúce placebo,

- celkovo **318 pacientov** (159 v každom ramene),
- hodnotenie v interim bode: **po 39 týždňoch**.

Primárny cieľ bol zameraný na **geometrický priemer pomeru 24-hodinovej proteinúrie** (pomeru bielkovín ku kreatinínu v moči, UPCR) v 39. týždni vzhľadom na východiskovú hodnotu. Bezpečnosť sa hodnotila súbežne.

Výsledky účinnosti (39. týždeň)

Proteinúria

Telitacicept v interim analýze viedol k výrazne väčšiemu poklesu proteinúrie než placebo:

- zmena 24-hodinového UPCR:
    - **telitacicept: −58,9 %**,
    - **placebo: −8,8 %**;
- relatívny rozdiel medzi ramenami (pomer geometrických priemerov redukcií): **−55,0 %** (95 % CI **−61,3 až −47,6**; p

Funkcia obličiek

Aj vývoj funkcie obličiek bol v 39. týždni priaznivejší pre telitacicept:

- zmena odhadovanej glomerulovej filtrácie (eGFR) od východiskovej hodnoty:
    - **telitacicept: −1,0 %** (95 % CI **−3,2 až 1,2**),
    - **placebo: −7,7 %** (95 % CI **−9,9 až −5,4**).

Tento údaj treba interpretovať opatrne: ide o interim bod a eGFR sa zvyčajne mení pomaly, preto jej zmeny v kratšom horizonte nemusia automaticky znamenať dlhodobý nefroprotektívny efekt.

Bezpečnosť

Bezpečnostné údaje sú pri imunomodulačných terapiách v IgAN zásadné.

- výskyt nežiaducich udalostí (akéhokoľvek typu): **89,3 %** (telitacicept) vs **78,6 %** (placebo),
- závažné nežiaduce udalosti: **2,5 %** (telitacicept) vs **8,2 %** (placebo),
- pri telitacicepte neboli hlásené **neočakávané bezpečnostné nálezy**.

Telitacicept teda prináša vyššiu celkovú mieru nežiaducich udalostí, závažné udalosti sa však v interim dátach javia ako menej časté než pri placebe. Rozhodujúce bude, ako sa bezpečnosť prejaví v pokračujúcej časti štúdie a či sa rozdiely udržia v dlhšom horizonte.

Nefrologická interpretácia: čo tieto dáta znamenajú v praxi

1. **Silný antiproteinurický efekt:** pokles proteinúrie o takmer 59 % oproti 8,8 % pri placebe je veľký a klinicky relevantný. Proteinúria je pri IgAN zavedený marker rizika progresie a jej zníženie sa často spája s lepšími renálnymi výsledkami.
2. **Signál na eGFR:** menší pokles eGFR v ramene s telitaciceptom je povzbudivý, ide však o interim hodnotenie.
3. **Bezpečnosť vyžaduje dlhšie sledovanie:** vyšší výskyt nežiaducich udalostí je prakticky dôležitý pre rozhodovanie o pomere prínosu a rizika, najmä ak by sa liek nasadzoval aj mimo úzko vybraných rizikových skupín.
4. **Imunomodulácia mení imunitné prostredie:** pri terapiách cieliacich BAFF/APRIL je biologicky očakávané zvýšenie rizík spojených s imunomoduláciou, hoci interim dáta neočakávané signály neukázali.

Limity interim analýzy

- ide o **vopred špecifikovanú priebežnú (interim) analýzu**, takže veľkosť efektu sa pri ďalšom sledovaní ešte môže zmeniť;
- primárny efekt stojí na **náhradnom (surrogátnom) ukazovateli** (proteinúria); hoci ide o veľmi užitočný marker, pre pacienta je rozhodujúce, či sa efekt v čase premietne do tvrdých klinických cieľov.

Záver

Pri vysokorizikovej IgA nefropatii s perzistujúcou proteinúriou **telitacicept v 39-týždňovej interim analýze významne znížil proteinúriu** oproti placebu a zároveň ukázal **menší pokles eGFR**. Nežiaduce udalosti boli častejšie, závažné udalosti v interim analýze naopak menej časté, bez neočakávaných bezpečnostných signálov. Pre zavedenie do praxe bude rozhodujúce, či pokračujúce výsledky potvrdia trvanie účinku a dlhodobú renálnu bezpečnosť.

Zdroj: *Lv J, Liu L, Wang W, et al.; TELIGAN Investigators. Telitacicept for IgA Nephropathy — Interim Analysis of a Phase 3 Trial. N Engl J Med. 2026;394(19):1916–1924. doi:10.1056/NEJMoa2514415 (TELIGAN, ClinicalTrials.gov NCT05799287). Spracované aj podľa súhrnu na portáli ReachMD „Telitacicept Interim Phase 3 Trial in IgA Nephropathy“: reachmd.com.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=telitacicept-iga-nefropatia-teligan-faza-3-interim · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.